

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	肝膿瘍的照護 Nursing care of Liver abscess				
編號	A31000-Q03-W-D07	制定者	N16 蔡富卿	公布日期	105 年 10 月 05 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	114 年 10 月 08 日
版本/總頁數	第 1.7 版/10 頁	審查者	曾翊健	檢閱日期	114 年 10 月 08 日

一、目的

讓護理人員了解肝膿瘍的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳照護品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

肝膿瘍是一種潛在的致命性疾病，死亡率高達 7.8~28.6%。當身體免疫力低下，例如糖尿病、接受化學治療、類固醇時，或是接受治療，例如肝臟穿刺、經皮穿肝膽道引流、肝動脈結紮等，此時若有病原體侵入肝臟，就有機會造成感染且形成肝膿瘍。肝臟膿瘍以細菌性感染居多，如：克雷白氏肺炎菌、腸道桿菌、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等。

（二）症狀

臨床上的表現最常見的是發燒，體溫可能高達 39°C 至 40°C、右上腹痛、肝脾腫大、黃疸、疲倦，另外肝膿瘍對於橫膈膜的刺激或是擴散至肺部感染可能會造成咳嗽、右肩痛、肋膜積水甚至造成膿胸情形，嚴重的則有敗血症、休克、腹膜炎或是肝臟破裂造成緊急開刀的狀況；若為克雷白氏肺炎菌(*Klebsiella pneumoniae*)所導致肝膿瘍，可能會有感染性眼內炎(endophthalmitis)的情況，視力衰退、眼球疼痛、結膜紅腫等症狀，恢復視力的預後不佳。因其突發性及多種不適症狀，包

主題名稱	肝膿瘍的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D07	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	2/10

括：發燒、疼痛、呼吸困難、休克、意識障礙等，使病人易有不確定感、失眠、焦慮等情緒表現。

（三）常見檢查

1. 抽血指標（WBC、alkaline phosphatase、CRP、血液細菌培養、Amebiasis Ab test IHA 法）。
2. 腹部超音波(Abdominal echo)。
3. 腹部電腦斷層掃描(Computerized Tomography)。
4. 腹部超音波導引下抽吸術或組織切片(Pus aerobic & anaerobic culture)。
5. 肝臟組織切片檢查(Liver biopsy)。

（四）常見治療

依照培養出的感染菌種而給予藥物治療或引流膿瘍治療以及症狀治療。

1. 藥物治療-細菌性肝膿瘍（注射抗生素治療二週，再給予口服抗生素治療三至六週，即使治療有效，發燒仍可能持續 1~2 週）
 - (1) Aminoglycoside
 - (2) Anti-anaerobic antibiotics
 - (3) Amoxicillin
 - (4) Cephalosporin
 - (5) Clavulanic acid
 - (6) Piperacillin
 - (7) Tazobactam
2. 藥物治療-阿米巴肝膿瘍（注射藥物或口服藥物治療五到十天，48-72 小時症狀若無好轉，考慮續發性感染或產生抗藥性）。
 - (1) Metronidazole(Flagyl)
 - (2) metronidazole(Anegyn)
 - (3) luminalagents(iodoquinol)
3. 引流膿瘍：

主題名稱	肝膿瘍的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D07	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	3/10

- (1) 細菌性肝膿瘍除了給予抗生素治療外，若膿瘍大於5公分以上還是建議合併引流的方式治療放置經皮穿肝膿瘍引流術(Percutaneous transhepatic abscess drainage , PTAD)引流可增加治療成效，經皮穿肝膿瘍引流術是藉由超音波及X光透視的輔助，用針穿刺肝臟至膿瘍處以達到引流膿瘍積液的方式，此方法適用於肝臟膿腫無法利用單純切開術治療時，而該膿腫位於穿刺針能安全到達的位置時。肝膿瘍引流方式也可以利用超音波導引的細針抽吸，細針抽吸常作為第一線治療及引流管放置，若是狀況緊急時，也可考慮電腦斷層導引(CT-guided)的引流管放置，若是治療效果差，則考慮外科引流。
- (2) 阿米巴肝膿瘍一般不需引流，抗生素治療即可，若治療效果不佳或是有破裂風險，則要考慮外科治療。

4. 症狀治療：常見不適症狀為疼痛情形，故常見的止痛藥物為：

- (1) 非鴉片類止痛藥物：Acetaminophen、Ketorolac(keto)、Voltaren、Stin。
- (2) 鴉片類止痛藥物：弱鴉片類有Codeine、Tramadol、Ultracet；強鴉片類有Morphine、Fentanyl。

(五) 護理問題

1. 易感染/和炎症過程有關。
2. 疼痛不適/與發炎過程有關。
3. 焦慮感受/因對病情變化的不確定感有關。

(六) 護理措施

1. 易感染/和炎症過程有關。
 - (1) 監測生命徵象的變化，發燒時協助冰枕使用及減少被蓋，調整室內空調，維持室溫在20-24°C間。
 - (2) 監測血液、尿液、細菌培養等檢驗數值。
 - (3) 協助調整衣服被蓋，維持身體清潔舒適與乾爽。
 - (4) 視需要補充水分及依醫囑予靜脈輸液。
 - (5) 依醫囑給抗生素治療。

主題名稱	肝膿瘍的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D07	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	4/10

(6) 依醫囑給予解熱鎮痛劑。

2. 疼痛不適/與發炎過程有關。

(1) 監測生命徵象、意識狀態及有無休克症狀。

(2) 觀察、進行急性疼痛評估（包含評估疼痛部位、特性、時間、頻率、性質、強度或嚴重度）與記錄，並告知醫師。

(3) 評估病人的疼痛指數，疼痛指數為病人生命徵象的第五徵象，臨床上使用十分量表與臉譜評估疼痛程度，評估方式為0分代表不痛到10分為最痛，臉譜評估則利用疼痛評量尺上的顏色和臉譜來表達，輕度疼痛 ≤ 3 分，中度疼痛4-6分，重度疼痛 ≥ 7 分。



(4) 若身上有放置引流管，在翻身或活動時應固定引流管處，以避免牽扯引流管可減少疼痛。

(5) 急性疼痛時，鼓勵多休息與採舒適姿勢臥床休息，減少干擾休息因素，以促進復原。

(6) 觀察病人不舒適的非語言暗示，特別是那些無法有效地溝通之病人。

(7) 確認病人有接受適當之止痛照護。

(8) 提供病人及家屬尋求及提供心理支持。

(9) 選擇疼痛緩解措施時，須考慮疼痛的型態及位置。

(10) 依醫囑給予適合之止痛藥，緩解疼痛。

(11) 評估病人的疼痛經驗，以評值疼痛控制措施的成效。

(12) 評估止痛藥之效果及有無副作用。

(13) 轉移其注意力，如聊天、聽音樂。

3. 焦慮感受/因對病情變化的不確定感有關。

主題名稱	肝膿瘍的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D07	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	5/10

- (1) 評估病人焦慮程度及主要原因。
- (2) 與病人建立信任關係，引導病人說出焦慮原因。
- (3) 對病人說話速度平靜緩慢，耐心傾聽病人主訴，尋找引起焦慮的原因。
- (4) 安排舒適環境並給予詳細的環境介紹，鼓勵病人討論其感覺和害怕。
- (5) 增加病人安全感，在做治療前給予詳細解釋。
- (6) 注意評估病人焦慮改善狀態。
- (7) 提供心理支持：陪伴並傾聽個案的抱怨，詢問需何種協助，使個案能有被關懷、重視的感受。
- (8) 請醫師解釋疾病發展過程協助病人確認可能的壓力來源。
- (9) 了解個案對相關疾病的認知，並鼓勵說出希望接受的治療方向。
- (10) 安排病人喜歡的環境，分散注意力，減輕焦慮，如：聽音樂、聊天。
- (11) 安排病人熟悉物品，如：玩具、照片、棉被、飾品等等，以減輕焦慮。
- (12) 經常探視並表示關懷，增加安全感，減少焦慮。
- (13) 若因焦慮導致夜眠時數減少或中斷次數增加，可採集中護理，避免噪音干擾，鼓勵臥床休息，以改善睡眠品質。

4. 置入豬尾巴引流管後的照護措施

- (1) 豬尾巴(Pigtail)引流管插入部位需將每天進行傷口換藥，換藥後將引流管牢固黏貼在胸壁或腹壁上，以避免拉扯滑脫。
- (2) 豬尾巴(Pigtail)引流管會以轉接頭連接引流袋進行引流，連接處使用紗布覆蓋，且放置位置要低於引流部位，以避免引流液回流，而造成感染或引流異常。
- (3) 引流袋至少每七天更換一次。
- (4) 醫療人員進行傷口換藥及管路照護時，需觀察傷口狀況有無滲濕或異常分泌物，並留意管路有無滑脫情形，有任何異常狀況應通知醫師進行處理。

(七) 衛教指導

1. 發燒時的護理衛教指導

主題名稱	肝膿瘍的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D07	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	6/10

- (1) 發燒時應減少被蓋，調整室內空調，維持室溫在 20-24℃間，保持身體清潔舒適與乾爽。
- (2) 冷敷法-使用冰枕或冰寶使用，並檢測冰枕與冰寶溫度隨時更換，約 2-3 小時更換一次。
- (3) 寒顫發抖時，可先加毛毯保暖，必要時給予烤燈，但寒顫停止高燒持續時，應慢慢移除毛毯；當出汗導致衣物潮濕時，應隨時協助病人更衣。
- (4) 若無限水醫囑，可多喝水，每日約 2500-3000ml，依照醫囑給予點滴補充水分及電解質。
- (5) 隨時量體溫及注意體溫變化，合宜水溫 40.5~43℃，以毛巾沾溫水輕拍身體四肢、腋下等部位。
- (6) 必要時打開窗戶，促進空氣流通。

2. 疼痛時的護理衛教指導

- (1) 急性疼痛時，鼓勵多休息與採舒適姿勢臥床休息，減少干擾休息因素來促進復原。
- (2) 教導可使用枕頭、被子、軟枕，或運用 U 型枕或 L 型枕協助舒適擺位，以達到病人最大舒適度。
- (3) 教導可藉由緩慢地深呼吸及吐氣、放鬆療法、冷熱敷（每次 10-15 分鐘，使用時需注意避免組織損傷，使用後可休息 5-10 分鐘再使用或更換部位）。
- (4) 使用認知上的減壓技巧，如：靜思、想像引導、看電視、聊天、聽音樂或鼓勵病人做一些有興趣的事情，減輕焦慮、分散對疼痛注意力、增加對疼痛忍耐力，以達減痛效果。
- (5) 轉移其注意力，如聊天、聽音樂。

3. 飲食的護理衛教指導

- (1) 以肝功能障礙一般飲食原則為主，教導採高熱量、高醣、高蛋白、低脂肪飲食為主，並避免辛辣油膩或有刺激性之食物，採少量多餐方式進食。

主題名稱	肝膿瘍的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D07	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	7/10

- (2) 肝臟是儲存維生素重要器官，肝臟發生病變會減少維生素的儲存，且維生素又是人體在代謝時不可或缺的物質，故可多攝取富含維生素食物，例如：芭樂、木瓜、番茄、深色蔬菜、胡蘿蔔。

4. 有放置豬尾巴引流管後的護理衛教指導

(1) 預防感染衛教指導：

- A. 臥床或下床時須保持引流袋低於腰部，以避免引流液回流造成感染。
- B. 勿將管路放置地上，以免踩到引流袋及造成感染。
- C. 暫時以擦澡方式替代沖澡來清潔身體，以保持插管部位傷口乾燥。

(2) 預防引流管滑脫的衛教指導：

- A. 下床活動與翻身擺位時，應注意管路擺放位置，避免受壓、扭曲及勿壓折到管路或拉扯，以避免滑脫發生；如不小心有拉扯到須立即告知醫護人員，以重新確認管路位置正確性。
- B. 放置豬尾巴(Pigtail)引流管對您或您的家人很重要，若病人有下意識拉扯管路行為，請告知醫療人員進行評估是否需進行預防性保護措施，例如使用棒球手套。
- C. 若醫療團隊評估後您或您的家人需要進行保護性約束，會徵詢您或您的家人的同意，若使用保護性約束裝置為約束帶，則將固定在床體，以避免拉扯到管路確保病人安全。
- D. 若是不小心拔除豬尾巴(Pigtail)引流管時，醫師會重新評估是否需要再放置，如需重新放置時則需要再安排檢查治療時間，在病房或檢查室幫您或您的家人放置豬尾巴引流管，敬請配合。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	肝膿瘍的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D07	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	8/10

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 李薇莉、周繡玲(2020)·消化系統疾病護理·於劉雪娥總校閱，內外科護理學下冊
(八版，459-468頁)·台北市：華杏。
- (二) 王主音、孫婉娜(2024)。照顧一位腹膜透析併肝膿瘍病人面對透析模式改變之護理經驗。馬偕護理雜誌，18(2)，72-82。[https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.29415/JMKN.202407_18\(2\).0007](https://doi-org.sw.lib.csmu.edu.tw:8443/10.29415/JMKN.202407_18(2).0007)

七、附件

(略)

主題名稱	肝膿瘍的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-D07	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	9/10

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
105.10.05	1.0	新制定	105 年 10 月 05 日護理部照護標準委員會通過；105 年 10 月 05 日公布
106.08.31	1.1	修訂第六項參考文獻資料	106 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
107.06.29	1.1	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.2	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第二目新增實證文獻、 3. 第三項第六、七目之 4 新增豬尾巴引流管的照護措施與護理衛教指導。 4. 第六項參考資料修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
108.09.23	1.3	第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 09 月 11 日護理長會議通過；108 年 09 月 23 日督導會議通過公布。
109.08.18	1.4	第六項參考資料修訂。	109 年 08 月 06 日照護標準組會議通過； 109 年 08 月 12 日護理長會議通過；109 年 08 月 18 日督導會議通過公布。
110.08.05	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.09.06	1.5	1. 第三項第一、二、七目說明內容文字修訂。 2. 更新第三項第五、六目護理問題。 3. 新增第六項參考文獻資料。 4. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 08 月 04 日照護標準組會議通過； 111 年 08 月 10 日護理長會議通過；111 年 09 月 06 日督導會議通過公布。
112.08.03	1.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

